

INFECCÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU)



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE: CISTITE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE DISÚRIA, POLACIÚRIA E DOR SUPRAPÚBICA, COM INÍCIO HÁ

NEGA FEBRE, NEGA NÁUSEAS E/OU VÔMITOS. NEGA OUTRAS QUEIXAS.

NEGA USO DE ANTIMICROBIANOS NOS ÚLTIMOS 90 DIAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: CISTITE

GERAL: BEG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DEFÍCITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUIDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (CISTITE), SEM SINAIS DE COMPLICAÇÃO.
- **CONDUTA:**
 - RECEITA MÉDICA COM ANTIMICROBIANO E SINTOMÁTICOS.
 - ORIENTAÇÕES GERAIS.
 - ATESTADO MÉDICO.
 - ORIENTO A SEGUIR ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL/EM UBS.
 - RETORNO CASO PIORA E/OU NÃO MELHORA.



ANAMNESE: PIELONEFRITE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE FEBRE AFERIDA, CALAFRIOS, DISÚRIA, DOR EM FLANCO E/D, QUEDA DO ESTADO GERAL, PROSTRAÇÃO, NÁUSEAS, VÔMITOS SEM ELEMENTOS PATOLÓGICOS, COM INÍCIO HÁ

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: PIELONEFRITE

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DEFÍCITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUIDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, DOR À PALPAÇÃO DE FLANCO/REGIÃO COSTOVERTEBRAL, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

PUNHO PERCUSSÃO LOMBAR POSITIVA À D/E.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
(PIELONEFRITE) SEM SINAIS DE
COMPLICAÇÃO.

- **CONDUTA:**

- RECEITA MÉDICA COM ANTIMICROBIANO E SINTOMÁTICOS.
- ORIENTAÇÕES GERAIS.
- ATESTADO MÉDICO.
- ORIENTO A SEGUIR ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL/EM UBS.
- RETORNO CASO PIORA E/OU NÃO MELHORA.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
(PIELONEFRITE) COM SINAIS DE
COMPLICAÇÃO.

- **CONDUTA:**

- SOLICITO INTERNAÇÃO HOSPITALAR
- INICIO ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL
- MANTENHO COM HIDRATAÇÃO VENOSA
- SINTOMÁTICOS DE HORÁRIO
- CADASTRO PACIENTE NA CENTRAL DE VAGAS

